

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

החייאה בסיסית לציבור הרחב

Cardio Pulmonary Resuscitation

C-A-B





- דום לב פתאומי מהווה גורם עיקרי למוות בעולם המערבי
- הרקע השכיח ביותר הינו מחלות לב וכלי דם
- החייאה בסיסית היא המפתח להצלת חיי אדם שעבר דום לב
- זיהוי מהיר, הזעקת עזרה וביצוע החייאה הכוללת שימוש בדפיברילטור הם אלו שיצילו את חייו של המטופל וישפיעו על סיכויי ההישרדות וההחלמה הנירולוגית שלו





מאפייני החיים

- נשימה תאית
- הזנה והפרשה
- רבייה
- תגובה לצורך הישרדות
- הומאוסטאזיס – שמירה על סביבה טבעית קבועה



גוף



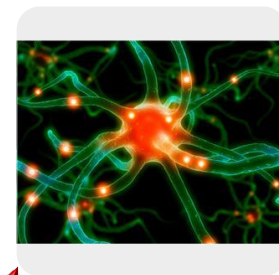
מערכת



איבר



רקמה

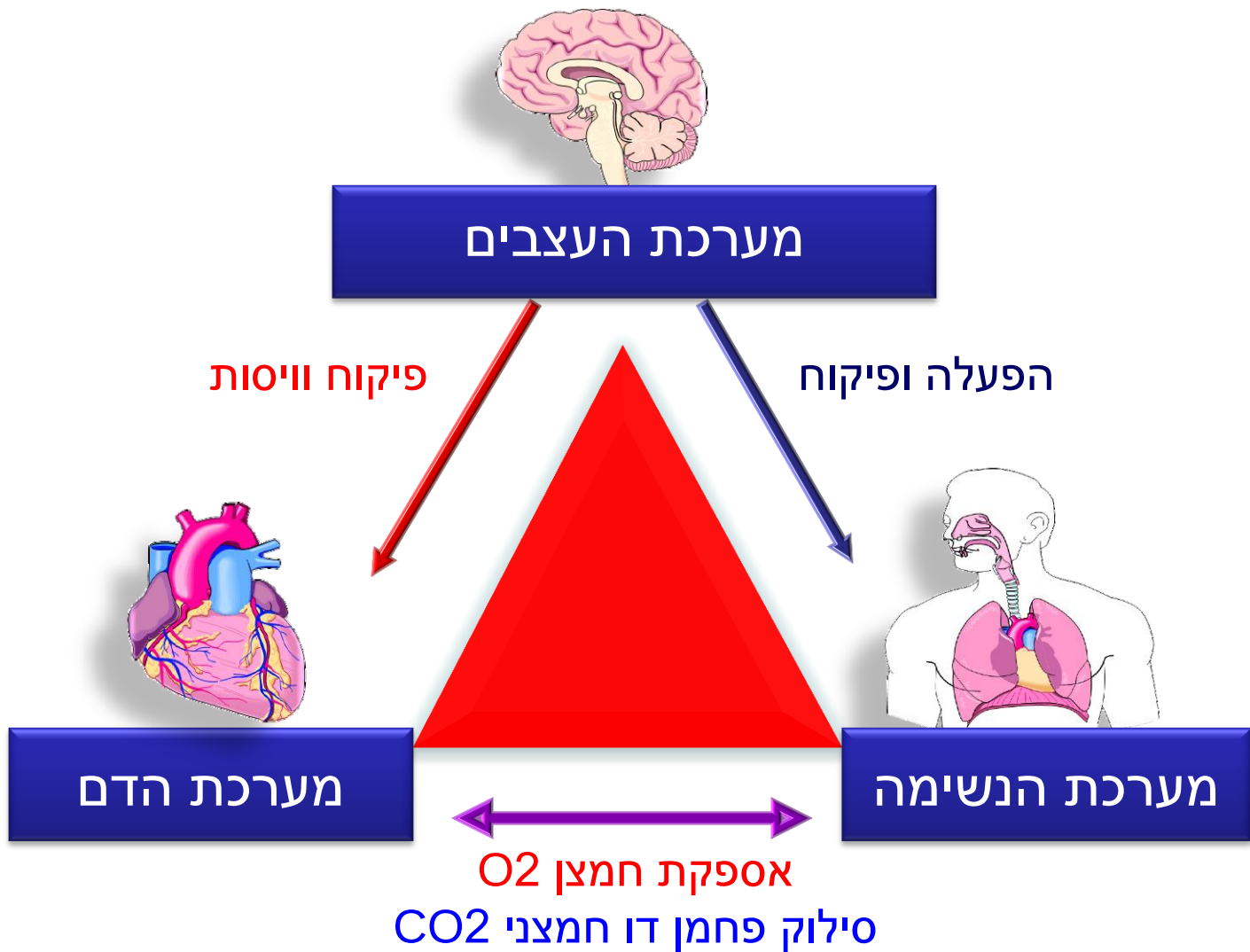


תא



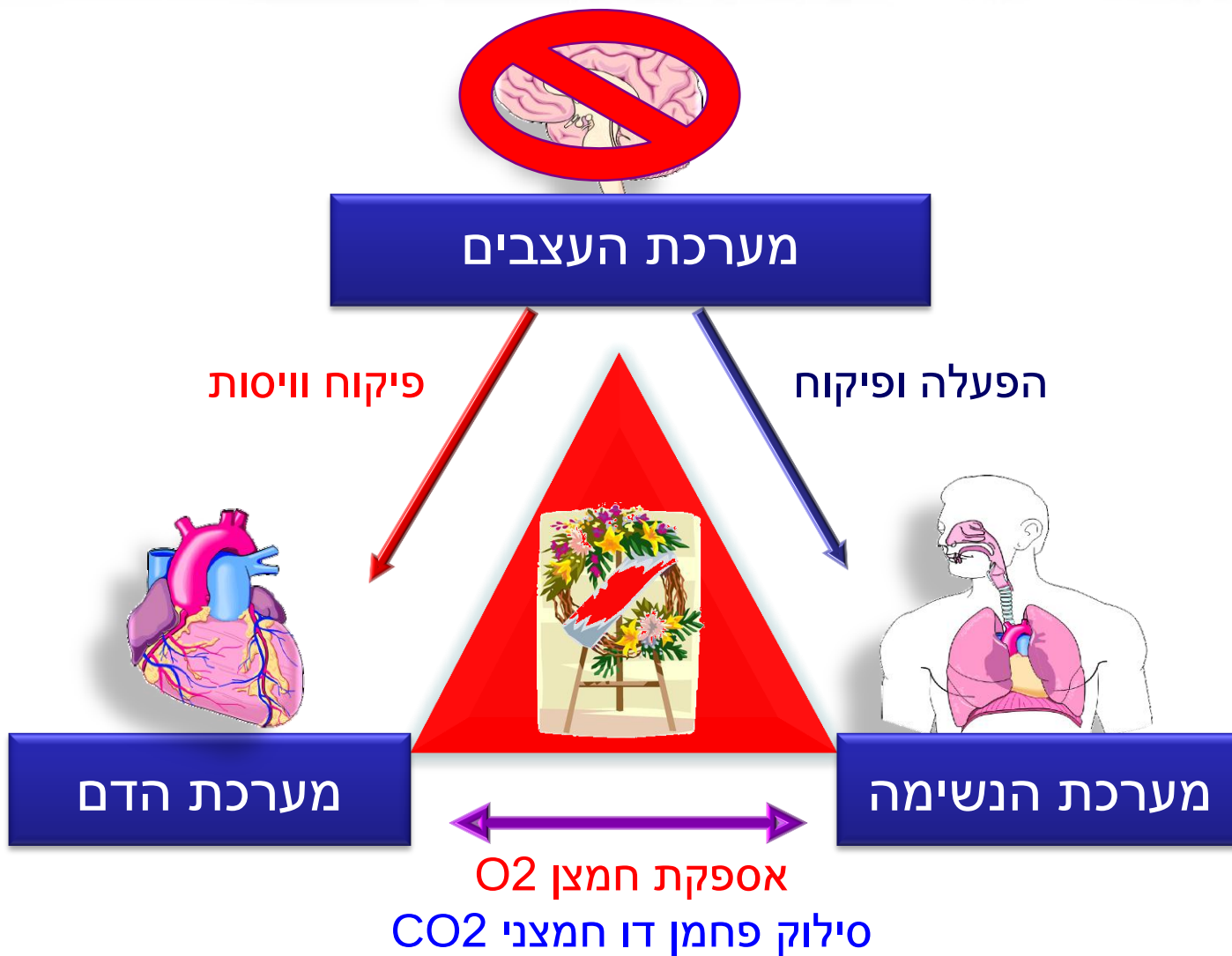


משולש החיים





פגיעה במשולש החיים





דום לב

מוות קליני

מוות מוחי



- מוות קליני – אין דופק, אין נשימה – מצב הפיך
 - מוות מוחי – אין דופק, אין נשימה – מצב בלתי הפיך
 - הזמן בין מוות קליני ועד למוות מוחי הינו כ- 4-6 דקות
 - החייאה מוקדמת תשפר את סיכויי ההישרדות ואת ההחלמה
- הנוירולוגית של המטופל





שרשרת ההישרדות

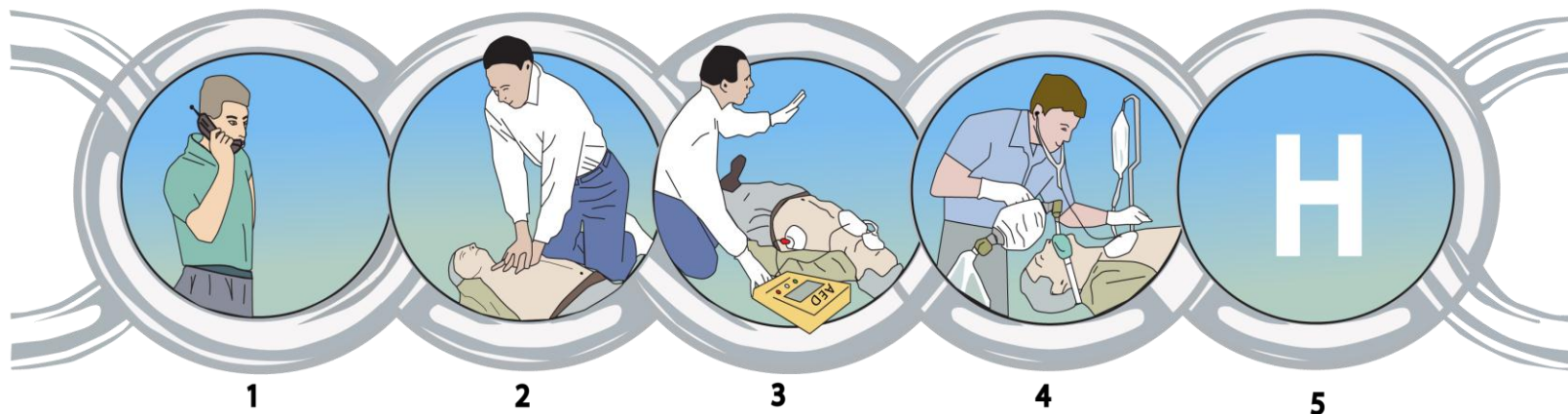
1. זיהוי מוקדם של דום לב, הזעקת עזרה ודפיברילטור

2. החייאה מוקדמת בדגש על עיסויי חזה

3. שוק חשמלי מוקדם כאשר יש התוויה לכך

4. החייאה מתקדמת

5. טיפול לאחר החייאה



1

2

3

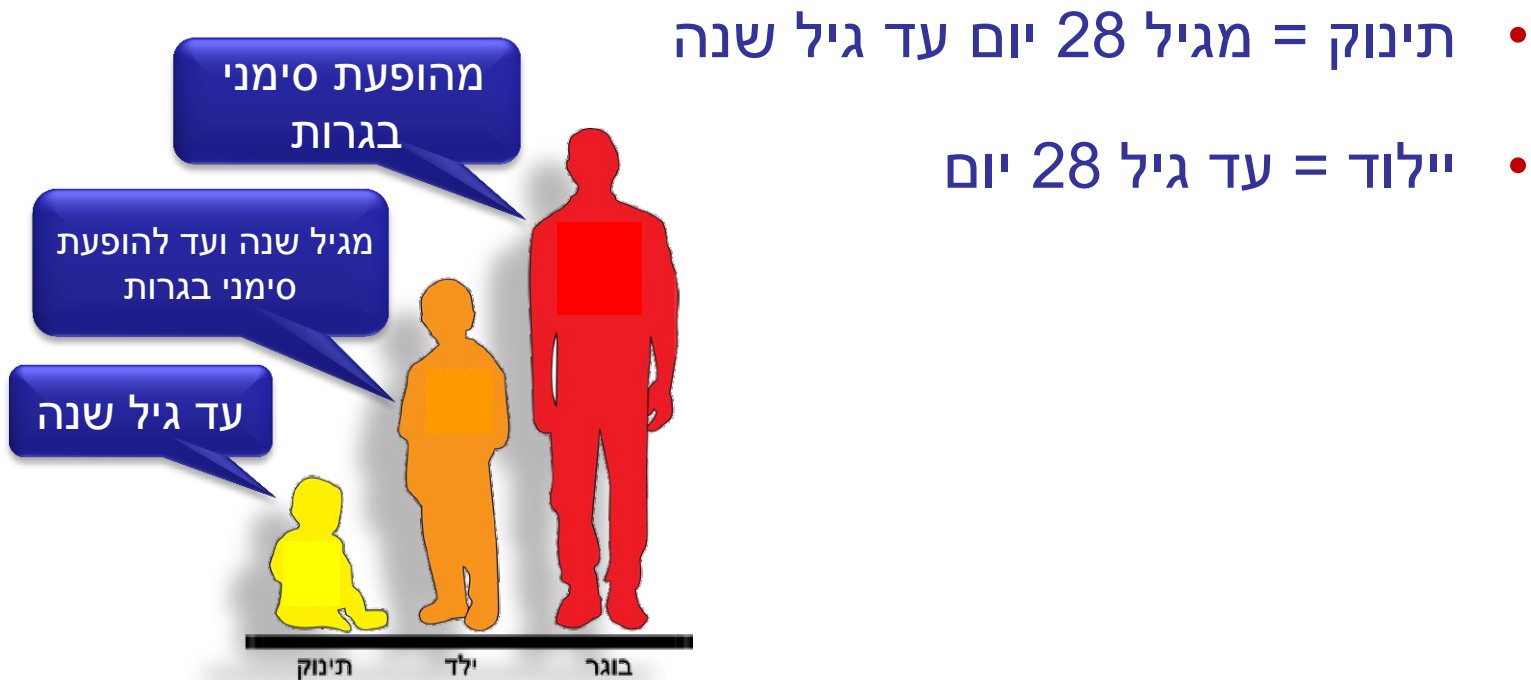
4

5



הגדרת גילאים

- בוגר = מהופעת סימני בגרות
 - ילד = מגיל שנה עד להופעת סימני בגרות
- (בגברים- הופעת שיער בבית השחי, בנשים- הופעת שדיים)





- בטרם מתן כל טיפול רפואי מכל סוג שהוא, יש לוודא את בטיחותו האישית של המטפל, של הצוות ושל המטופל
- יש לפעול לנטרול סיכונים בזירת האירוע ולהרחיק את המטופל מגורמים מסכנים (טביעה, התחשמלות, שריפה וכדומה)
- במידת הצורך יש להזעיק כוחות נוספים



שימוש בכפפות





התרשמות מהירה מסימני חיים

בדיקת הכרה:

1. מילולית – פניה אל המטופל "אדוני.. אדוני?"

2. פיזית – צביטת המטופל בשרירי הטרפז



בדיקת הכרה פיזית

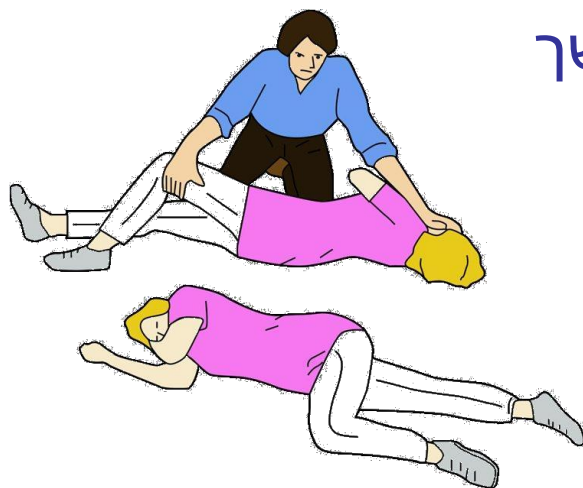




התרשמות מהירה מסימני חיים

התרשמות מהירה ממצב הנשימה:

- יש להסיר בגדים מבית החזה של המטופל ולהביט על בית החזה
 - אם המטופל נושם, יש להטות אותו לצד ולשמור על נתיב האוויר
 - אם המטופל אינו נושם או נושם "נשימות אחרונות" הזעק עזרה
- ועבור מייד לשלב ה-C כמפורט בהמשך



השכבה על הצד- תנוחת החלמה



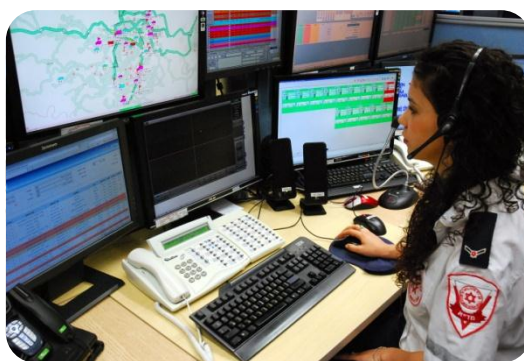


הזעקת עזרה

- יש להזעיק עזרה מייד כאשר מזוהה דום לב בחיוג 101 למד"א
- במידת האפשר יש להשיג דפיברילטור ולהשתמש בו בהקדם



קריאה לעזרה ולדפיברילטור



מוקד החירום של מד"א



ניידת טיפול נמרץ של מד"א





עיסויי חזה- C

- כאשר לא זוהו סימני חיים ולאחר הזעקת עזרה יש לבצע עיסויים
- יש לבצע עיסויים חזק ומהר!
- מיקום העיסויים הוא במרכז בית החזה בין הפטמות
- קצב עיסויים של לפחות 100 עיסויים בדקה
- החלפת המעסה תתבצע כל 2 דקות
- מספר העיסויים לסבב החייאה הינו 30 עיסויים
- יש לבצע הערכה מחודשת כל 2 דקות של החייאה





אופן ביצוע העיסויים

- יש לבצע עיסויים חזק ומהר!
- יש לעסות באמצעות שתי ידיים בעומק של לפחות 5 ס"מ מעומק בית החזה ובקצב של לפחות 100 עיסויים בדקה
- יש להקפיד על חזרה מלאה של בית החזה בין עיסוי לעיסוי



עיסויי חזה במבוגר



לחץ חזק ומהר, במרכז בית החזה





נתיב אוויר - A

- יש לפתוח את הפה ולסלק הפרשות אם ישנן (עד 10 שניות)
- כאשר אין חשד לטראומה, יש להטות את המטופל על צידו
- יש לפתוח נתיב אוויר בשיטת "מצח סנטר" - Head Tilt- Chin Lift



פתיחת נתיב אוויר - מצח סנטר



סילוק הפרשות למבוגר





- יש לספק 2 הנשמות מפה לפה או באמצעות מסכת כיס
- עד להתרוממות בית החזה של המטופל ולא יותר משנייה אחת
- יש להימנע מהנשמת יתר
- הנשמה מפה לפה הינה לשיקול דעתו של המטפל
- אם המטפל אינו רוצה להנשים, עליו לבצע "החייאת ידיים בלבד"



הנשמה באמצעות מסכת כיס



הנשמה מפה לפה





- בטוחה לשימוש
- מאפשרת הנשמה דרך הפה והאף של המטופל
- מתאימה למבוגרים, לילדים ולתינוקות
- מאפשרת ביצוע החייאה המשלבת עיסויים והנשמות
- אם ההנשמה אינה יעילה (בית החזה אינו מתרומם):
 - שפר אטימת המסכה על הפה והאף
 - שפר קיבוע הראש לאחור
 - שפר את נפח ההנשמה





- יש לחבר את המכשיר בהקדם האפשרי לבית החזה של המטופל ולפעול בהתאם להנחיותיו
- לאחר מתן שוק חשמלי יש לבצע מייד עיסויים
- אם אין המלצה לשוק, יש להמשיך ולבצע 2 דקות של החייאה



מיקום המדבקות במבוגרים



מיקום המדבקות במבוגרים





חשיבות השימוש בדפיברילטור

- הדפיברילטור הינו מכשיר אוטומטי ופשוט לשימוש
- קיימת חשיבות רבה לשימוש בדפיברילטור במהלך ההחייאה
- המכשיר נותן שוק חשמלי דרך קיר בית החזה במטרה לאפשר חזרת קצב לב יעיל שיוביל לחזרת פעילות לבבית ספונטאנית
- בכל דקה בה המטופל בפרפור חדרים ולא מקבל שוק חשמלי סיכויי ההישרדות שלו פוחתים ב- 7%-10%





הפעלת המכשיר

1. הדלק את המכשיר

2. חבר את המדבקות לבית החזה של המטופל

3. פעל בהתאם להנחיות המכשיר

פתח את
המכשיר
להדלקה



1



2



מתן שוק

3

שלבי תפעול דפיברילטור אוטומטי





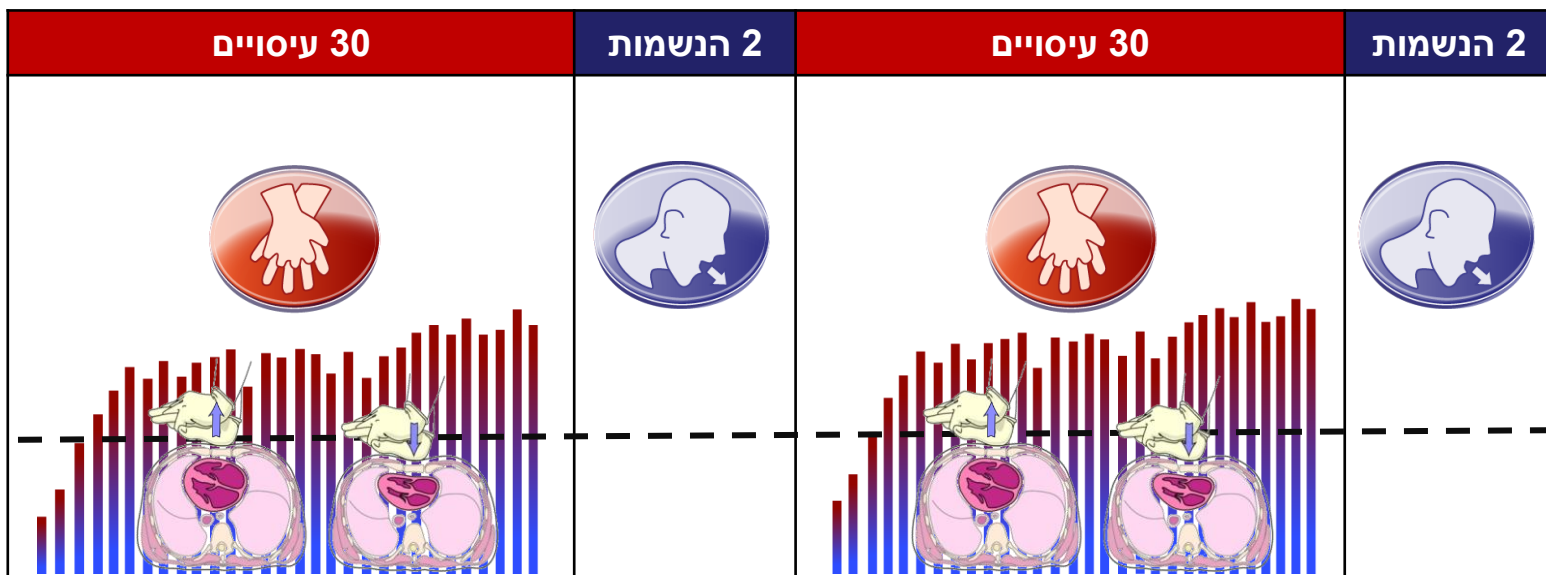
פרפור חדרים - VF

- חדרי הלב "מפרפרים" ואינם מצליחים לייצר דופק מכאני
- הסכנה הגדולה ביותר בשעות הראשונות שלאחר אירוע לבבי
- מטופל עם פרפור חדרים יהיה ללא דופק וסימני חיים
- הטיפול בפרפור חדרים (VF) הינו החייאה מוקדמת ומתן שוק
- חשמלי בהקדם האפשרי על מנת לשפר את סיכויי ההישרדות





חשיבות רצף העיסויים



פרפוזיה
קורונרית
הולמת





סבב החייאה

- יחס עיסויים- הנשמות של 30:2 מהווים סבב החייאה אחד
- על המטפל לבצע הערכה מחדשת כל חמישה סבבים/ 2 דקות
- הדפיברילטור יאבחן כל 2 דקות האם ישנו קצב הדורש שוק חשמלי
- אם הדפיברילטור אינו ממליץ על מתן שוק חשמלי, יש להמשיך ולבצע החייאה למשך 2 דקות נוספות
- אם הופיעו סימני חיים, יש לשמור על נתיב האוויר עד להגעת צוותי

מד"א





החייאת מבוגרים



1



2



3



4



5

לא מגיב ולא נושם
או נושם "נשימות
אחרונות"



קריאה לעזרה- 101



התחל החייאה

C → A → B



תן שוק אם מומלץ.
הערוך קצב באמצעות
הדפיברילטור כל שתי דקות

לחץ חזק ומהר!



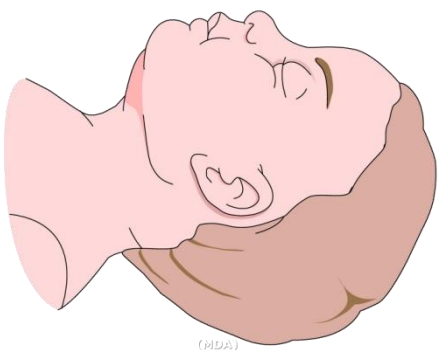
MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

החייאת ילדים ותינוקות

C-A-B



(גפנים)



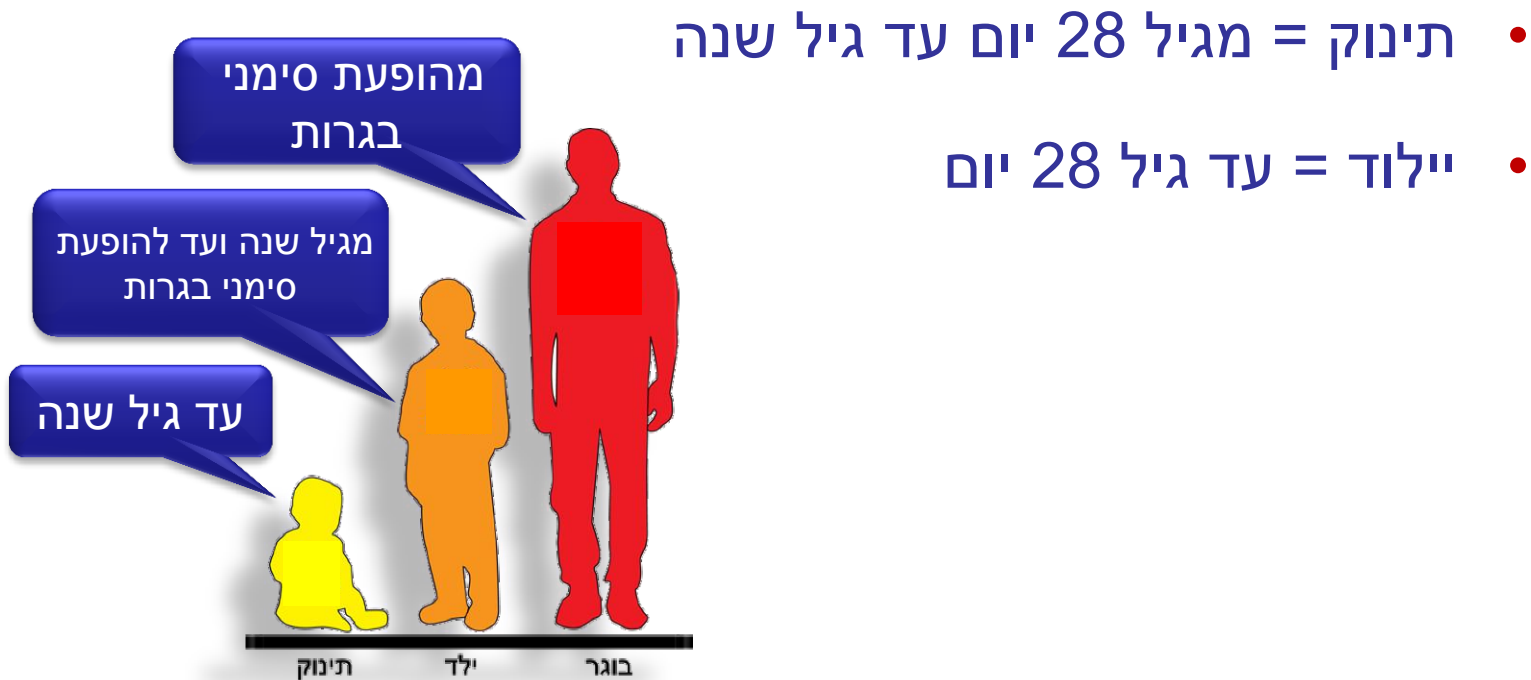
- בניגוד למבוגרים, הסיבה העיקרית לדום לב בילדים ובתינוקות איננה לבבית
- הסיבות העיקריות נובעות מהחמרה של כשל נשימתי והלם
- כשל נשימתי והלם יכולים להיות הפיכים אם יזוהו ויטופלו בזמן





הגדרת גילאים

- בוגר = מהופעת סימני בגרות
 - ילד = מגיל שנה עד להופעת סימני בגרות
- (בגברים- הופעת שיער בבית השחי, בנשים- הופעת שדיים)





שרשרת ההישרדות בילדים

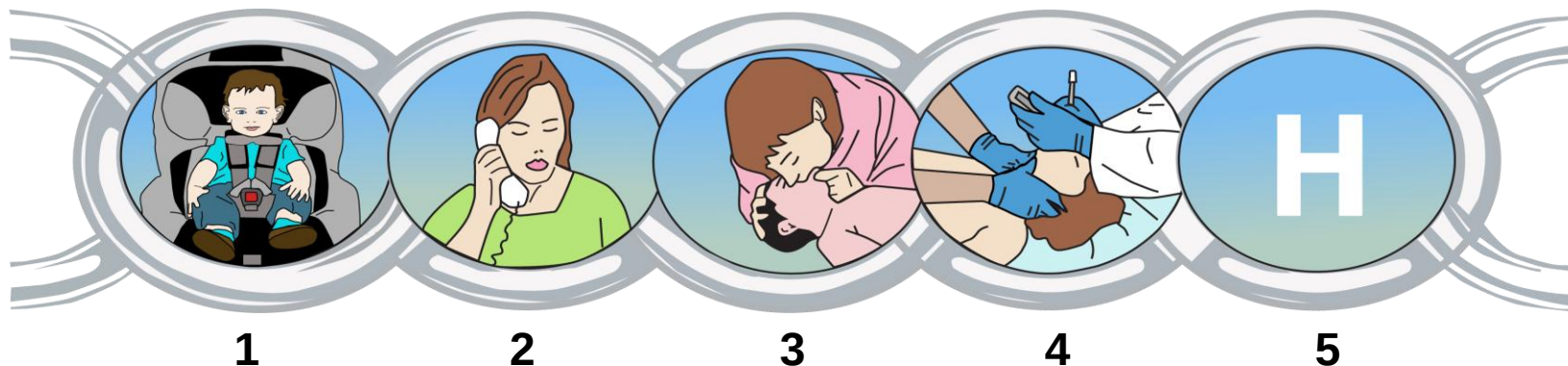
1. מניעה והסברה

2. קריאה לעזרה

3. החייאה בסיסית

4. החייאה מתקדמת

5. טיפול לאחר החייאה



1

2

3

4

5





- בטרם מתן כל טיפול רפואי מכל סוג שהוא, יש לוודא שנשמרת בטיחותו האישית של המטופל, של הצוות ושל המטופל
- יש לפעול לנטרול סיכונים בזירת האירוע ולהרחיק את המטופל מגורמים מסכנים (טביעה, התחשמלות, שריפה וכדומה)
- במידת הצורך יש להזעיק כוחות נוספים



העברה למצע קשיח





התרשמות מהירה מסימני חיים

בדיקת הכרה בילדים:



בדיקת הכרה פיזית בילדים

1. מילולית – פניה אל המטופל "ילד ילד?"

2. פיזית – צביטת המטופל בשרירי הטרפז

בדיקת הכרה בתינוקות:



בדיקת הכרה פיזית בתינוקות

1. מילולית – מחיאת כף, ניסיון לגירוי מילולי

2. פיזית – שפשוף או צביטה בכפות הרגליים

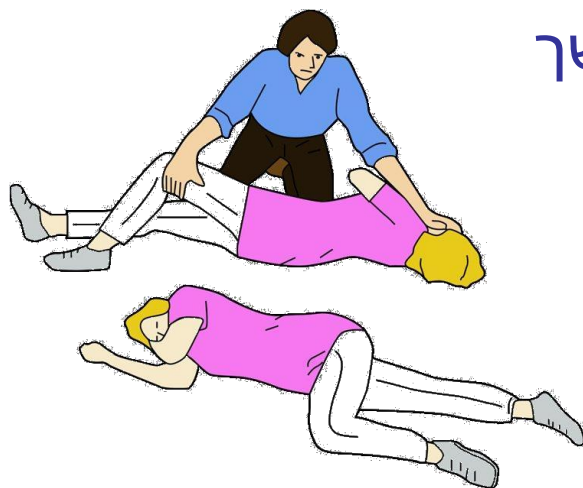




התרשמות מהירה מסימני חיים

התרשמות מהירה ממצב הנשימה:

- יש להסיר בגדים מבית החזה
 - אם המטופל נושם, יש להטות אותו על צידו ולשמור על נתיב האוויר
 - אם המטופל אינו נושם או נושם "נשימות אחרונות" הזעק עזרה
- ועבור מייד לשלב ה- C כמפורט בהמשך



השכבה על הצד- תנוחת החלמה





הזעקת עזרה

- כאשר מדובר בזוג מטפלים, בדומה להחייאת מבוגר, יש להזעיק עזרה מייד ולהשיג דפיברילטור בהקדם
- כאשר מדובר במטפל יחיד יש לבצע קודם 2 דקות החייאה ורק לאחר 2 דקות לקרוא לעזרה



קריאה לעזרה ולדפיברילטור



מוקד החירום של מד"א



ניידת טיפול נמרץ של מד"א





- כאשר לא זוהו סימני חיים ולאחר הזעקת עזרה יש לבצע עיסויים
- יש לבצע עיסויים חזק ומהר!
- מיקום העיסויים הוא במרכז בית החזה בין הפטמות
- קצב עיסויים של לפחות 100 עיסויים בדקה
- יש לבצע הערכה מחודשת ולהחליף את המעסה כל 2 דקות
- יש להקפיד על חזרה מלאה של בית החזה בין עיסוי לעיסוי
- יש לבצע הערכה מחודשת כל 2 דקות של החייאה





אופן ביצוע העיסויים

- בילדים: יש לעסות באמצעות יד אחת או שתיים (עפ"י גודל הילד) ובעומק של לפחות 5 ס"מ מעומק בית החזה
- בתינוקות: יש לעסות באמצעות שני אגודלים או באמצעות שתי אצבעות ובעומק של לפחות 4 ס"מ מעומק בית החזה



טכניקת האגודלים



עיסויים בתינוק



עיסויים בילד





נתיב אוויר- A

- יש לפתוח את הפה ולסלק הפרשות אם ישנן (עד 10 שניות)
- בילדים: כאשר אין חשד לטראומה, יש להטות את המטופל הצידה
- בתינוקות ניתן להפוך את המטופל על היד של המטפל
- יש לפתוח נתיב אוויר בשיטת "מצח סנטר"- Head Tilt- Chin Lift



מצח סנטר לילד



מצח סנטר לתינוק



סילוק הפרשות לתינוק





- יש לספק 2 הנשמות מפה לפה/ לפה והאף או באמצעות מסכת כיס
- עד להתרוממות בית החזה של המטופל ולא יותר משנייה אחת
- יש להימנע מהנשמת יתר
- הנשמה מפה לפה ואף היא לשיקול דעתו של המטפל



הנשמת ילד באמצעות מסכת כיס



הנשמת תינוק מפה לפה ואף





- יש לחבר את המכשיר בהקדם האפשרי לבית החזה של המטופל
- בילדים קטנים ובתינוקות יש להניח מדבקה אחת בקדמת בית החזה ומדבקה שנייה על גבו של המטופל ולפעול בהתאם להנחיותיו של המכשיר



מיקום המדבקות בילדים



מיקום המדבקות בתינוקות





סבב החייאה

- יחס עיסויים- הנשמות 30:2 מהווה סבב החייאה אחד
- על המטפלים לבצע הערכה מחודשת כל חמישה סבבים/ 2 דקות
- הדפיברילטור יאבחן כל 2 דקות האם ישנו קצב הדורש שוק חשמלי
- אם הדפיברילטור אינו ממליץ על מתן שוק חשמלי, יש להמשיך ולבצע החייאה למשך 2 דקות נוספות
- אם הופיעו סימני חיים, יש לשמור על נתיב האוויר עד להגעת צוותי

מד"א





סיכום מרכיבי ההחייאה

מרכיב	מבוגרים	ילדים	תינוקות
זיהוי	אינו מגיב (בדיקה מילולית ופיזית)		
	אינו נושם או נושם "נשימות אחרונות"		
רצף החייאה	C-A-B		
קצב עיסויים	לפחות 100 עיסויים בדקה		
עומק עיסויים	לפחות 5 ס"מ	לפחות 1/3 מעומק בית החזה (בערך 5 ס"מ)	לפחות 1/3 מעומק בית החזה (בערך 4 ס"מ)
אופן ביצוע עיסויים	שתי ידיים	יד אחת או שתיים	שני אגודלים או שתי אצבעות
חזרת בית חזה	הקפד על חזרה מלאה של בית החזה בין עיסוי לעיסוי בצע החלפה של איש הצוות המעסה בכל 2 דקות		
נתיב אוויר	שיטת מצח סנטר- Head Tilt- Chin Lift		
יחס עיסויים- הנשמות	מטפל יחיד: 30:2 זוג מטפלים: 30:2	מטפל יחיד: 30:2 זוג מטפלים: 30:2	
הנשמה יעילה	הנשמה יעילה: עד לעליית בית החזה של המטופל ובאורך של עד שנייה אחת		
דפיברילטור	יש לחבר ולהשתמש בדפיברילטור ברגע שהוא זמין ככלל, יש לצמצם את ההפרעות לביצוע עיסויים לפני ואחרי מתן שוק חשמלי לאחר מתן שוק חשמלי יש לבצע מייד עיסויים		





החייאת ילדים



1



2



3



4



5

החייאת תינוקות



1



2



3



4



5



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?

